Приложение № ___
к Приказу Министра
здравоохранения
Республики Узбекистан
№____ от «____» _____2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ»

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 г .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ»

ТАШКЕНТ – 2025

"СОГЛАСОВАНО"
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Х.Г. Фозилов

_____

_____ _____ 2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ»

ТАШКЕНТ 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кодирование по МКБ-10:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
I10	Эссенциальная [первичная] гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I11	Гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I11.0	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I11.9	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист

I12	Гипертония касаллиги буйрак шикастланиши устунлиги билан	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I12.0	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I12.9	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I13	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I13.0	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I13.1	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист

I13.2	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I13.9	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточненная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I15	Вторичная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I15.0	Реноваскулярная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог,	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог,

			реаниматолог, нефролог, окулист		реаниматолог, нефролог, окулист
I15.8	Другая вторичная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
I15.9	Вторичная гипертензия неуточненная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
O13	Гипертензия, вызванная беременностью, без значительной протеинурии (гестационная гипертензия).	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист

Кодирование по МКБ-11:	**Нозологическое название:**	**Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях**		**Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения**	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
BA00	Эссенциальная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA00.0	Систоло-диастолическая	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург,	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург,

	артериальная гипертензия		невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист		невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA00.1	Изолированная диастолическая артериальная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA00.2	Изолированная систолическая артериальная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA00.Y	Другая уточненная эссенциальная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA00.Z	Эссенциальная гипертензия, неуточненная	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA01	Гипертоническая болезнь с поражением сердца	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA02	Гипертоническая болезнь с поражением почек	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист

BA04	Вторичная гипертензия	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист
BA03	Гипертонический криз	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист	Кардиолог/Терапевт/Реаниматолог	Эндокринолог/Специалист по основной болезни, ангиохирург, невропатолог, реаниматолог, нефролог, окулист

***при заполнении стандарта необходимо выяснить нозологию, ее течение у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также особенности периода заболевания по нозологии. Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, если по нозологии не ведется хирургическая практика, таблица (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ) не заполняется, или если нозология не включает паллиативное лечение - не заполняется таблица (ПАЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ).**

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диагностика	Название медицинских услуг	По уровню и виду медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		СВП/ СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
Консультация главного специалиста (врача)	1.Врач общей практики	+					ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО низкий/средний 1 раз в год	Амбулаторное (диспансерное) наблюдение пожизненно; Стационарное лечение: 5-10 дней*
	2.Терапевт		+	+	+		ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год	
	3. Кардиолог		+	+	+	+	ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 4 раза в год	
Примечание: * длительность стационарного лечение в зависимости от цели госпитализации. В стационарных условиях ежедневный осмотр специалистов.								
Консультация (врача) специалиста (дополнительно)	1.Эндокринолог		+	+	+	+	При необходимости*	
	2.Невропатолог		+	+	+	+	1 раз в год	
	3.Офтальмолог		+	+	+	+	1 раз в год	
	4.Нефролог				+	+	При необходимости*	

	5.Сосудистый хирург				+	+	При необходимости*	
Примечание: * консультации дополнительных специалистов проводятся для исключения метаболических нарушений, сахарного диабета, вторичной АГ, ХБП								
Основные лабораторные анализы	1.Общий анализ крови	+	+	+	+	+	ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО низкий/средний 1 раз в год ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 2 раза в год	
	2.Общий анализ мочи	+	+	+	+	+		
	3.Глюкоза	+	+	+	+	+		
	4.Коагулограмма	+	+	+	+	+		
	5.Мочевая кислота		+	+	+	+		
	6.Креатинин	+	+	+	+	+		
	7.ОХС		+	+	+	+		
	8.Триглицериды		+*	+	+	+		
	9.ЛПНП		+*	+	+	+		
	10.ЛПВП		+*	+	+	+		
	11. Микроальбуминурия (МАУ)		+*	+	+	+		
	12.МАУ/креатинин		+*	+	+	+		
Примечание: * если позволяет материально-техническая база СВП/СП семейным врачам рекомендуется сделать анализ полного липидного спектра, мочевой кислоты и МАУ в условиях СВП/СП. В стационарных условиях лабораторные исследования проводятся в зависимости от клинического состояния больных.								
Дополнительные лабораторные анализы	1.Электролиты			+	+	+	При необходимости*	
	2.Общий биллирубин			+	+	+		
	3.АСТ			+	+	+		
	4.АЛТ			+	+	+		
	5.ТТГ			+	+	+		
	6.Кортизол				+	+		
	7.Альдостерон				+	+		
	8.АКТГ				+	+		
	9.Ренин				+	+		
	10.Моча на катехоламины				+	+		
Примечание: * для исключения сопуствующих заболеваний и вторичной эндокринной АГ								

Основные инструментальные исследования	**1.ЭКГ**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО низкий/средний 1 раз в год ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 2 раза в год**	
	2.ЭхоКГ			**+**	**+**	**+**		
	3.УЗИ сонных артерий и внутренних органов		**+**	**+**	**+**	**+**		
	4.Суточный мониторинг артериального давления				**+**	**+**		
П р								
Дополнительные инструментальные исследования	**1.Спектральная допплерография почечных аретрий**				**+**	**+**	**См. примечание**	
	2. Ангиография почечных артерий				**+**	**+**		
	3. КТ надпочечников, гипофиза				**+**	**+**		
	4. КТ или МРТ головного мозга				**+**	**+**		
Примечание: дополнительные инструментальные исследования проводятся с целью исключения вторичной АГ								

Диагностика	**Название медицинских услуг**	**По уровню и виду медицинской помощи**					**Минимальное количество сервисов или проверок**	**Продолжительность лечения**
		Амбулаторное лечение		**Стационарное лечение**				
		СВП/СП	**МПЦП**	**Районные (городские) больницы**	**Медицинские учреждения областного уровня**	**Медицинские учреждения Республиканского уровня**		
Другие виды обследования	**1. Протокол PEN***	**+**	**+**				**При каждом осмотре**	

							патронажной медсестры	
	2.Шкала SCORE	+	+	+	+	+	При каждом осмотре ВОП	
	3. MMSE тест	+	+	+	+	+	При каждом осмотре ВОП	
	4. Шкала МОСА				+	+	При каждом осмотре пациентов с III стадией ГБ	
Примечание: * PEN протокол ВОЗ подходит для раннего скрининга взрослого населения старше 40 лет и оценки сердечно сосудистого риска								

(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ)

Диагностические аспекты (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду медицинской помощи					Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Названия лекарственного средства (не запатентованного на международном уровне)	Дозировка и способ применения препарата*	СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
Ингибиторы ангиотензин-преаращающего фермента (иАПФ)								В амбулаторных условиях-постоянно
1. Эналаприл	5, 10, 20 мг 2 раза в день	+	+	+	+	+	20 мг/сут	
2.Лизиноприл	10, 20 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	10 мг/сут	
3.Рамиприл	5-10 мг 1 раз вдень	+	+	+	+	+	10 мг/сут	
4.Периндоприл	Периндоприл аргинин 5-10 мг 1 раз в день Периндоприл эрбумин 4-8 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	5 мг/сут	
Антагонисты/блокаторы рецептора 1-типа ангиотензина II (АРА/БРА)								
5.Вальсартан	80-160 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	80 мг/сут	
6.Лозартан	25, 50, 100 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	50 мг/сут	

7.Ирбесартан	150-300 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	150 мг/сут
8.Телмисартан	40-80 мг 1 раз вдень	+	+	+	+	+	40 мг/сут
9.Олмесартан	20-40 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	40 мг/сут
10. Азилсартан	40-80 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	40 мг/сут
Антагонисты кальция (АК)							
11. Амлодипин	5-10 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	5 мг/сут
12. Лерканидипин	10-20 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	10 мг/сут
13. Нифедипин	10 мг 3 раза в день	+	+	+	+	+	10 мг/сут
14. Нитрендипин	10-20 мг 2 раза в день						20 мг/сут
Тиазидовые/тиазидоподобные диуретики							
15. Индапамид	1,25-2,5 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	2,5 мг/сут
16. Гидрохлортиазид	12,5-25 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	12,5 мг/сут
17. Хлорталидон	12,5-25 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	12,5 мг/сут
Петлевой диуретик							
18. Торасемид	5-10 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	5 мг/сут
Бета-адреноблокаторы							
19. Бисопролол	2,5; 5, 10 мг 1-2 раза в день	+	+	+	+	+	5 мг/сут
20. Метопролол	25, 50, 100 мг 1-2 раза в день	+	+	+	+	+	50 мг/сут
21. Небиволол	5-10 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	5 мг/сут
22. Карведилол	6,25; 12,5 мг 1-2 раза в день	+	+	+	+	+	12,5 мг/сут
Антиагреганты **							
23. Ацетилсалициловая кислота	75, 100, 150 мг 1 раз вдень	+	+	+	+	+	75 мг/сут
24. Аторвастатин	10, 20, 40 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	20 мг/сут
25. Розувастатин	5, 10, 15, 20, 40 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	10 мг/сут
Примечание: * способ применения согласно инструкции; ** - при диагностике атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний							
Меры лечения (дополнительная лекарственная терапия)		По уровню и виду медицинской помощи			Средняя суточная доза	Дозировка на один курс	
		Амбулаторное лечение	Стационарное лечение				

Названия лекарственного средства (не запатентованного на международном уровне)	Дозировка и способ применения препарата*	СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
1. Спиронолактон	25-50 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	25 мг/сут	В амбулаторных условиях- постоянно
2. Эплеренон	25-50 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	25 мг/сут	
3. Моксонидин	0,2-0,4 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	0,4 мг/сут	
4. Доксазозин	2-4 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	2 мг/сут	
5. Празозин	2-4 мг 1 раз в день	+	+	+	+	+	2 мг/сут	
6. Метилдопа	250 мг 3 раза в день	+	+	+	+	+	750 мг/сут	
7. Урапидил	5 мл			+	+	+	5 мл	В стационарных условиях для купирования гипертонического криза
8. Фуросемид	40 мг (2 мл)	+	+	+	+	+	2 мл	В стационарных условиях для купирования гипертонического криза
9. Магнезиум сульфат	25% 250 мг/мл			+	+	+	5 мл	В стационарных условиях для купирования гипертонической энцефалопатии при преэклампсии
Примечание: * способ применения согласно инструкции								

(ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Диетический стол и его продолжительность	СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня
1. Стол №10	+	+	+	+	+

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

Меры диспансеризации	Название медицинских услуг	СВП/СП	МПЦП	Минимальное количество мер	Период диспансерного контроля
Консультация (врача) специалиста	1.Патронажная медсестра	+	+	ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО низкий/средний – 1 раз в год ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 4 раза в год	пожизненно
	2.Врач общий практики	+	+		
	3.Кардиолог		+		
	4.Невролог		+		
	5.Офтальмолог		+		
	6.Эндокринолог		+		
Примечание:					
лабораторные анализы	1. Общий анализ крови	+	+	ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО	
	2. Общий анализ мочи	+	+		
	3. Общий белок	+	+		
	4. Глюкоза крови	+	+		

	5. Электролиты крови: калий, натрий, кальций		+	низкий/средний 1 раз в год ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 2 раза в год	пожизненно
	6. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+		
	7. Липидный спектр крови		+		
	8. Креатинин крови	+	+		
	9. Мочевая кислота крови		+		
	10. Микроальбуминурия		+		
	11. Отношение Микроальбуминурия/креатинин		+		
	12. Гликированный гемоглобин*		+		
	13.ТТГ*		+		
	14.Коагулограмма*		+		
	15. Креатинфосфокиназа*				
	16. С-реактивный белок*				
	17. МНУП*				
	18. Тропонин*				
	19. Ферритин*				
	20. Фибриноген*				
Примечание: * При необходимости по показаниям					
инструментальные исследования	1. Рентгеноскопия грудной клетки		+	ГБ I стадии. Степень АГ Риск ССО низкий/средний 1 раз в год ГБ II стадии. Степень АГ Риск ССО высокий 2 раза в год ГБ III стадии. Степень АГ Риск ССО очень высокий 2 раза в год	пожизненно
	2.ЭКГ	+	+		
	3.ЭХОКГ		+		
	4. УЗИ внутренних органов		+		
	5. УЗИ брахиоцефальных артерий		+		
	6. Суточное мониторирование АД*				
	7.ХМЭКГ•		+		
	8				
	9. МСКТ-ангиография•				
	10. Коронарография•				

Примечание: * Суточное мониторирование АД рекомендуется проводить в дополнение к измерениям в кабинете врача, для выявления гипертензии “белого халата”, скрытой гипертензии и фенотипов пациентов с ночной гипертензией, а также для уточнения диагноза истинной резистентной гипертензии. • При необходимости по показаниям.